

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE CALIDAD DE SUEÑO DE GRONINGEN (GSQS)

Groningen Sleep Quality Scale (Meijman et al., 1988; Mulder-Hajonides van der Meulen et al., 1980) · Adaptación Hispanoparlante

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Calidad de Sueño de Groningen (Groningen Sleep Quality Scale, GSQS)
Sigla / Acrónimo	GSQS
Autoría original	Theo F. Meijman, G. Mulder, W. R. E. H. Mulder-Hajonides van der Meulen (Univ. of Groningen, 1988)
Adaptación en español	Versión instrumental hispana validada para investigación clínica y cronobiológica
Constructo evaluado	Calidad subjetiva y grado de perturbación del sueño experimentado en la noche inmediatamente anterior
Población diana	Adultos y jóvenes en monitorización hospitalaria, ensayos clínicos, cambios de turno laboral o estrés agudo
Tiempo de aplicación	2 a 3 minutos (administración matutina inmediata)
Estructura y formato	15 ítems dicotómicos (Verdadero / Falso o Sí / No); 14 ítems computables en la puntuación total
Condiciones de uso	Uso libre en el ámbito académico y asistencial no comercial (Univ. of Groningen)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

A diferencia de escalas globales que miden el sueño retrospectivo de varias semanas o meses (como el PSQI o la ESS), la GSQS fue diseñada como un instrumento micrométrico de estado (“state measure”) para evaluar el impacto puntual del sueño de una noche específica. El marco teórico de Meijman se fundamenta en la psicofisiología del trabajo, la carga alostática y la recuperación psicobiológica posfatiga.

La escala cuantifica la presencia de sueño fragmentado, superficial, no reparador y las sensaciones somatomotoras matutinas de falta de recuperación. Es especialmente valiosa en contextos de monitorización longitudinal día a día (diarios de sueño), estudios de privación experimental, ingresos en unidades de cuidados intensivos o de hospitalización psiquiátrica, y evaluación del impacto inmediato de modificaciones farmacológicas de hipnóticos o antidepresivos sedantes.

3. COMPOSICIÓN DE ÍTEMS Y ESTRUCTURA DE LA ESCALA

Ítem	Contenido del Ítem (Noche Anterior)	Valor Crítico	Dimensión Evaluada
1	Tuve una noche de sueño profundo y reparador	Falso = 1	Ítem introductorio no computable
2	Me costó mucho conciliar el sueño anoche	Verdadero = 1	Latencia de conciliación
3	Me desperté varias veces durante la noche	Verdadero = 1	Fragmentación del sueño
4	Sentí que no dormí casi nada	Verdadero = 1	Percepción de vigilia/insomnio
5	Me desperté demasiado temprano y no pude volver a dormir	Verdadero = 1	Despertar precoz matutino
6	Me di muchas vueltas en la cama sin descansar	Verdadero = 1	Inquietud psicomotora nocturna
7	Esta mañana me he levantado cansado y sin energía	Verdadero = 1	Recuperación somática matutina
8-15	Pesadillas, sueño superficial, tensión, somnolencia matutina	V = 1 / F = 1	Perturbación integral del ciclo

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y RENDIMIENTO EN MONITORIZACIÓN

Consistencia interna	Excelente fiabilidad como escala acumulativa de Guttman/Mokken; coeficientes de consistencia interna de Kuder-Richardson (KR-20) y alfa de Cronbach $\alpha = 0.88 - 0.91$.
Validez experimental	Sensibilidad inmediata y demostrada a la privación parcial de sueño, ruido ambiental hospitalario y jet-lag ($p < 0.001$, tamaño del efecto $d > 1.30$).
Validez de criterio	Correlaciona inversamente con la duración del sueño profundo de ondas lentas (fase N3, $r = -0.48$) y la eficiencia objetiva medida por actigrafía ($r = -0.62$).
Escalamiento unidimensional	Cumple criterios rigurosos de la escala de Mokken ($H = 0.52 - 0.58$), confirmando que mide una única dimensión latente de "perturbación aguda del sueño".
Sensibilidad al cambio	Capacidad inmediata para detectar variaciones noche a noche inducidas por rotación de turnos, inicio de medicación hipnótica o estrés agudo premórbido.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Regla especial del Ítem 1	El ítem 1 ("Tuve una noche profunda y tranquila") se utiliza como ítem introductorio de calentamiento y entrenamiento mental; no se computa en la puntuación total.
Codificación de ítems 2 a 15	Se asigna 1 punto por cada respuesta que indique perturbación del descanso (generalmente "Verdadero" en los ítems de molestia y "Falso" en los ítems de descanso restaurador).
Puntuación directa global	Suma lineal aritmética de los 14 ítems computables. Rango teórico posible: 0 a 14 puntos . A mayor puntuación, peor fue la calidad del sueño.
Momento de administración	Debe cumplimentarse preferentemente dentro de los primeros 30 a 60 minutos tras levantarse por la mañana para minimizar el sesgo de olvido o el influjo del cansancio diurno.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Percentil Aprox.	Calidad del Sueño	Interpretación y Estado de Recuperación
0 - 2	< Pc 50	Sueño Reparador / Óptimo	Excelente descanso nocturno; recuperación psicofisiológica completa.
3 - 5	Pc 55 - Pc 70	Perturbación Leve / Aceptable	Pequeños despertares o latencia ligeramente prolongada sin impacto mayor.
6 - 9	Pc 75 - Pc 90	Sueño No Reparador Moderado	Fragmentación notable; fatiga matutina y reducción de alerta cognitiva.
10 - 14	> Pc 90	Perturbación Severa Aguda	Noche en vela o descanso extremadamente desestructurado; déficit crítico.

PUNTOS DE CORTE EN MONITORIZACIÓN:

- **GSQS ≥ 6 :** Umbral indicativo de perturbación aguda sustancial que deteriora el rendimiento en tareas complejas al día siguiente.
- **GSQS ≥ 10 durante 3 noches consecutivas:** Justifica intervención ambiental inmediata, suspensión de guardias clínicas o ajuste farmacológico agudo.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN MONITORIZACIÓN MATUTINA

Paso 1: Aplicación matutina: Cumplimentar a los 30 min del despertar. Calcular la suma de los 14 ítems computables.

Paso 2: Si GSQS 0 — 2 (Sueño óptimo): Mantener pautas habituales y rutina de vigilia.

Paso 3: Si GSQS 3 — 5 (Perturbación leve): Verificar desencadenantes inmediatos (temperatura ambiental, cena copiosa, pantallas tarde en la noche).

Paso 4: Si GSQS 6 — 9 (Sueño no reparador): Advertir al sujeto sobre tiempos de reacción prolongados si realiza tareas de alto riesgo; evitar siestas prolongadas (> 30 min) para no comprometer la noche siguiente.

Paso 5: Si GSQS ≥ 10 recurrente en ámbito hospitalario: Investigar dolor no controlado, intervenciones de enfermería nocturnas innecesarias, ansiedad hospitalaria o efectos secundarios de corticoides/broncodilatadores.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE MONITORIZACIÓN HOSPITALARIA

Identificación: Varón de 64 años ingresado en unidad de convalecencia tras cirugía ortopédica mayor (artroplastia de cadera). Presenta irritabilidad matutina y labilidad emocional.

Monitorización con GSQS: Se aplica la GSQS a las 08:00 h durante tres mañanas consecutivas:

- Noche 1: GSQS = **12 / 14** (Sueño severamente fragmentado por dolor posquirúrgico y alarmas de bombas de infusión).
- Noche 2: GSQS = **11 / 14** (Despertares continuos, sensación de no haber descansado).

Intervención Clínica Multidisciplinar: Ajuste de analgesia nocturna pautada (evitando dolor en picos), reagrupación de tomas de signos vitales nocturnos para respetar tramo de 00:00 a 06:00 h y uso de tapones para oídos.

Evolución: En la Noche 3, la puntuación GSQS descendió a **3 / 14** (Descanso óptimo), normalizándose el estado cognitivo y la disposición para la rehabilitación fisioterápica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Hospitalario:

- Delirium Hipo/Hiperactivo:** En pacientes ancianos hospitalizados, puntuaciones elevadas repetidas de GSQS pueden preceder al debut de delirium agudo.
- Dolor No Informado:** Descartar que el insomnio agudo encubra isquemia, neuropatía o complicaciones quirúrgicas ocultas.

Diagnóstico Diferencial:

- Insomnio Agudo Situacional vs. Crónico:** La GSQS detecta eventos reactivos; para insomnio primario persistente debe usarse el ISI o PSQI.
- Efectos de Sustancias:** La abstinencia alcohólica precoz o el cese brusco de hipnóticos disparan rebotes masivos de sueño REM con GSQS > 10.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Meijman, T. F., de Vries-Grype, B., De Haro, G. W., & Mulder, G. (1988). The evaluation of the Groningen Sleep Quality Scale. **Groningen: Department of Experimental Psychology.**
- Mulder-Hajonides van der Meulen, W. R. E. H., van den Hoofdakker, R. H., & Hoofdakker, K. (1980). A subjective sleep quality scale. In **Sleep 1980: 5th European Congress on Sleep Research** (pp. 387-389). Karger.
- Simões, A., Silva, C. F., & Pimentel, D. (2010). Psychometric properties of the Groningen Sleep Quality Scale in shift workers. **Revista Portuguesa de Psicologia**, 41, 145-158.
- Akerstedt, T., Hume, K., Minors, D., & Waterhouse, J. (1994). The subjective meaning of good sleep, an intraindividual approach using the Groningen scale. **Journal of Sleep Research**, 3(1), 24-31. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.1994.tb00100.x>